Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95080-155 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5027954-07.2024.8.21.0010/RS

AUTOR: KAREN ADRIANA DA ROCHA (PAIS)

AUTOR: EMANUEL DA ROCHA PALAVRO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

EMANUEL DA ROCHA PALAVRO, representado pela genitora KAREN ADRIANA DA ROCHA ajuizou ação de cobrança contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.**, partes qualificadas na lide.

A genitora do autor narrou que Emanuel é portador de doença rara, neuromuscular, degenerativa, progressiva e grave, de origem genética – doença do neurônio motor: Doença de Werdnig-Hoffmann (CID-10 G12.0), também denominada de Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q) do Tipo 1, comprovada por exame genético de sequenciamento de genes SMN1 e SMN2 – deleção por exon 7 e 8 do SMN1. Referiu que foi prescrito o medicamento ZOLGENSMA, pelo conceituado neurologista, Dr. Alulin Fonseca - CRM-SP 152.426, especializado em Doenças Neuromusculares, o qual foi fornecido pela União ao autor, em abril/2024. Disse que buscou junto à operadora de saúde a possibilidade de internação e aplicação do medicamento, pelo plano de saúde; porém, foi informada pela ré que não possuía profissionais habilitados, e, ainda, que no Estado do Rio Grande do Sul não poderia ser feita a aplicação da medicação Zolgensma. Também foi negado pela ré o custeio do valor a ser despendido para aplicação da medicação. Alegou que foi obrigada a buscar atendimento no Hospital Angelina Caron, situado no Estado do Paraná, cuja médica neuropediatra, Dra. Adriana Banzatto, é especializada na aplicação do medicamento, tendo os familiares realizados empréstimos para obter o valor para realizar a infusão, que ocorreu no dia 12-4-2024. Referiu que o valor despendido com a internação foi de R$48.268,39 *(Internação hospitalar: R$ 17.846,40; Aplicação do medicamento pela médica especialista: R$ 9.980,00; Fisioterapia motora e respiratória: R$ 14.571,99; Fisioterapia motora – período de transporte: R$ 2.800,00; Fonoaudiologia e terapia ocupacional: R$ 3.070,00),* no período de 11-4-2024 a 01-5-2024. Salientou que o preço do medicamento é de 8 a 12 milhões de reais, a depender da dose que a criança irá tomar, trata-se de dose única. Busca o ressarcimento do valor despendido para aplicação do medicamento Zolgensma. Discorreu sobre a atrofia muscular espinhal (AME). Invocou a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova. Requereu a procedência da ação, com condenação da ré a reembolsar o valor despendido para aplicação/infusão do medicamento ZOLGENSMA, no importe de R$ 48.268,39, devendo ser acrescido de juros e correção até o efetivo pagamento. Postulou a concessão do benefício da AJG. Atribuiu à ré os ônus sucumbenciais. Deu à causa o valor de R$60.000,00. Juntou documentos - Evento 1.

Concedido o benefício de assistência judiciária gratuita à parte autora - Evento 10.

Citada, a demandada contestou - Evento 18. Esclareceu que o autor é beneficiário dependente de contrato de assistência à saúde, modalidade coletivo empresarial, firmado entre MARCOPOLO S.A e a ora requerida, Unimed Nordeste RS, com data de inclusão em 24/03/2023. Referiu que o autor pede seja custeado a aplicação e internação para aplicação do medicamento: ZOLGENSMA, no Hospital Ange – Curitiba/PR, conforme requisitado, sendo informado que as coberturas existentes são aquelas que possuem previsão legal e contratual, bem como o plano de saúde do autor é REGIONAL, não fornecendo serviços fora da área de abrangência. Alegou que não se trata de urgência/emergência, razão pela qual se faz necessário observar a previsão contratual da rede credenciada e a ausência de cobertura nos termos do contrato. Afirmou que não existe como garantir qualquer cobertura e/ou reembolso para procedimentos sem previsão regulamentar e realizados fora da área geográfica de abrangência prevista no contrato firmado entre as partes. Discorreu sobre a ausência de cobertura para o tratamento solicitado, não se encontram previstos na lista de eventos e procedimentos em saúde da ANS. Sustentou a taxatividade do Rol da ANS. Ao final, pediu a improcedência da ação. Atribuiu à parte autora os ônus sucumbenciais.

Seguiu-se réplica - Evento 23.

Intimadas, a ré requereu o julgamento antecipado da lide - Evento 33; e a parte autora postulou a prova pericial e audiência de conciliação - Evento 34.

Remetido o processo ao CEJUSC, não houve conciliação - Evento 58.

Indeferido o pedido de prova pericial - Evento 66.

Sobreveio parecer do Ministério público - Evento 72.

Relatei. Decido.

Cabível o julgamento antecipado do feito no estado em que se encontra, na hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as partes não postularam outras provas.

A pretensão da parte autora é de que a ré seja obrigada a reembolsar os valores despendidos com a internação para a aplicação da medicação Zolgensma, no valor de R$48.268,39 *(Internação hospitalar: R$ 17.846,40; Aplicação do medicamento pela médica especialista: R$ 9.980,00; Fisioterapia motora e respiratória: R$ 14.571,99; Fisioterapia motora – período de transporte: R$ 2.800,00; Fonoaudiologia e terapia ocupacional: R$ 3.070,00),* no período de 11-4-2024 a 01-5-2024.

A ré, por sua vez, sustentou que as coberturas existentes são aquelas que possuem previsão legal e contratual, bem como o plano de saúde do autor é REGIONAL, não fornecendo serviços fora da área de abrangência. Afirmou que não se trata de urgência/emergência, razão pela qual se faz necessário observar a previsão contratual da rede credenciada e a ausência de cobertura nos termos do contrato.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Consoante laudo médico do evento 1, LAUDO9, emitido pelo Dr. Alulin Fonseca, especialista em neurologia infantil, o autor Emanuel foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I. Disse que o paciente é elegível para o tratamento com o Onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma), sendo a única terapia gênica disponível para o tratamento da doença. Afirmou que a terapia se mostrou eficaz em interromper a progressão da doença, bem como promover melhora do ponto de vista motor e respiratório.

Destaco o seguinte trecho do laudo médico:

> Desta maneira, o uso do Zolgensma beneficiará o paciente Emanuel da Rocha Palavro com a interrupção da progressão da doença, além do ganho de função motora em membros superiores e inferiores para melhor desempenho nas atividades de vida diária. Além disso, haverá, sobretudo, benefício em sua função ventilatória, a fim de evitar o aumento de tempo em ventilação mecânica invasiva. Atualmente, a criança tem capacidade de se manter 3 horas seguidas sem ventilação mecânica, o uso de Zolgensma poderá levar a melhora da função respiratória, diminuindo a necessidade de tempo de ventilaçao diário. Ademais, haverá benefício também da função bulbar, a qual engloba a capacidade de deglutição e da fala, podendo haver possibilidade de retorno de dieta por via oral. A diminuição de infecções respiratórias, bem como complicações ortopédicas, também são benefícios esperados, diminuindo assim as internações hospitalares e procedimentos cirúrgicos.
> Os riscos da não utilização da medicação são piora progressiva da fraqueza muscular e das funções respiratória e bulbar. A progressão da doença promove a necessidade de internações hospitalares repetidas e prolongadas, geralmente em unidade de terapia intensiva, além de diversos procedimentos cirúrgicos. Além disso, ocorrerá uma piora inequívoca da qualidade de vida da paciente e de toda a sua família.
> Solicito, portanto, a liberação com urgência desta medicação, sob o risco iminente de piora das funções motoras globais.

Diante do diagnóstico do autor, foi indicada pelo médico assistente a aplicação da medicação Zolgensma com urgência, para fins de interromper a progressão da doença.

No caso, a parte autora teve a medicação fornecida pela União, conforme relatado na inicial, buscando apenas que o plano de saúde cubra os custos com a internação para aplicação da medicação.

A Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022 que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim dispõe acerca da internação hospitalar e reembolso de valores:

> Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**
>
> **(...)**
>
> II - quando incluir internação hospitalar:
>
> a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos;

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; **(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)**

(...)

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

Consoante a Lei n. 14.454, que alterou a lei 9.656/1998, editada em 21-9-2022, indica que o rol da ANS constitui referência básica no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, ou seja, é meramente exemplificativo.

"[...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, **constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.**

§ 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Ao contrário do que foi afirmado pela demandada, desde o ano de 2023 a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a incorporação do medicamento Onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, para tratamento de pacientes pediátricos com até 6 meses de idade com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I.

Ainda, constou na noticia divulgada no site da ANS [1]:

"O Zolgensma® é a primeira terapia avançada a integrar a lista de coberturas obrigatórias pelas operadoras de planos de saúde, cuja incorporação ao Rol está ocorrendo em atendimento ao que determina o parágrafo 10 da Lei 14.307, de março de 2022: "As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), instituída pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias"."

Não fosse isso, oportuno esclarecer que a limitação do critério médico na escolha de procedimento para o tratamento da doença é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica, *in verbis:*

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente".

Dessa forma, cabe ao médico assistente, o qual é conhecedor do quadro clínico, determinar qual o tipo de tratamento mais adequado ao caso, prescrever os métodos e os procedimentos mais indicados para o paciente, bem como os materiais e medicamentos que deverão ser utilizados.

Ou seja, é vedado ao plano de saúde insurgir-se contra as determinações do médico quanto aos medicamentos e materiais utilizados no procedimento e que objetivam reduzir os riscos do paciente e, em consequência, os custos do plano de saúde, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, ainda, que haja recomendação pela Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Possuindo o contrato firmado pelas partes cobertura de tratamento para a moléstia apresentada pela parte autora, como no caso da presente demanda, não pode o plano, agora, negar-se a arcar com as despesas de internação para aplicação da medicação fornecida pela União, alegando: *a exclusão da cobertura para os procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, ausência de urgência/emergência, ausência de cobertura fora da abrangência territorial,* uma vez que preenchido todos os outros requisitos, quais sejam: cobertura para moléstia apresentada; medicamento descrito para indicação da bula; registro do medicamento na ANVISA; medicamento previsto no rol da ANS.

Desse modo, mostra-se abusiva qualquer negativa sob a justificativa de que o medicamento não está no rol da ANS.

Segundo constou na inicial, a ré negou o atendimento afirmando que não possuía profissionais habilitados - Evento 1, INIC1, fls. 3-4.

> Então, foi prescrito o medicamento **ZOLGENSMA**, pelo conceituado neurologista, Dr. Alulin Fonseca - CRM-SP 152.426, especializado em Doenças Neuromusculares (anexo).
>
> Zolgensma é um medicamento de terapia gênica usado para tratar a atrofia muscular espinhal. Foi aprovado para crianças menores de dois anos em 2019.
>
> O medicamento foi fornecido pela União ao autor em abril de 2024.
>
> Ato contínuo, a genitora do menor buscou junto à operadora de saúde a possibilidade de internação e aplicação do medicamento, pelo plano de saúde.
>
> **É que, para receber a aplicação desse medicamento contra a AME, é preciso estar internado em um leito hospitalar**.
>
> Contudo, foi informada pela ré que não possuía profissionais habilitados, e, ainda, que no Estado do Rio Grande do Sul não poderia ser feita a aplicação da medicação Zolgensma.
>
> O autor, requereu ao seu plano de saúde que custeasse o valor a ser gasto, já que não tinha profissional capacitado para a aplicação, tampouco disponibilizou hospital para a aplicação do fármaco.
>
> Contudo, recebeu um verdadeiro NÃO da parte ré, sob a frágil alegação de que o plano de saúde é regional, e não abarcava o pedido (anexo).
>
> Por esse motivo, a mãe do autor viu-se obrigada a buscar atendimento no Hospital Angelina Caron, situado no Estado do Paraná, cuja médica neuropediatra, Dra. Adriana Banzatto, é especializada na aplicação do medicamento.
>
> Lutando contra o tempo, os familiares do autor recorreram a empréstimos, obtendo, então, o valor para que a infusão no menor.
>
> Assim, ocorreu a infusão no dia 12 de abril de 2024, no Hospital Angelina Caron - Araçatuba, Campina Grande do Sul - PR, sendo a médica responsável pelo procedimento a Dra. Adriana Banzatto (Neuropediatra/CRM 18667-PR).

Embora a parte autora não tenha apresentado comprovante de solicitação para internação para aplicação da medicação, observa-se que tal fato não foi impugnado pela demandada em contestação. Somente quando intimada para produção de provas, é que a ré alegou que a autora não comprovou ter solicitado autorização para aplicação da medicação - evento 33, PET1.

Anote-se que diante da ausência de impugnação, presume-se verdadeira a tese apresentada pela autora de que a ré negou a internação do autor porque não possuía profissional qualificado para aplicação da medicação, tornando-se o fato incontroverso, sendo dispensável prova nesse sentido, nos termos do art. 374, inciso III, do CPC.

Ademais, em nenhum momento a ré comprovou que possui em sua rede credenciada profissionais habilitados para realizar a aplicação da medicação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Após, diante da negativa na internação do autor para aplicação da medicação, foi requerido que a ré reembolsasse o valor despendido de R$48.268,39, e novamente houve negativa da ré sob a justificativa de que o contrato não tem previsão de reembolso para situações que não sejam de urgência ou emergência - evento 18, ANEXO3.

A situação de emergência prevista na cláusula 33ª inciso II, do contrato do plano de saúde -Evento 18, ANEXO4, fl.19, está comprovada pelo laudo do médico assistente, o qual prescreveu a medicação e pediu a liberação com urgência em face do risco de piora das funções motoras globais.

XVIII – ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Cláusula 33ª: É obrigatória por parte da CONTRATADA a cobertura do atendimento nos casos de:
I - urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; e
II - emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

Logo, a demora na aplicação da medicação agravaria a situação do autor, piorando as funções motoras globais.

Quanto ao reembolso, o contrato prevê o seguinte:

DO REEMBOLSO

Cláusula 38ª: Será garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da

cobertura contratual sempre que não for possível a utilização dos serviços de prestadores da rede assistencial deste plano.

Assim, tratando-se de situação de emergência, conforme laudo médico que requereu a liberação da medicação com urgência, cabível o reembolso integral das despesas tidas com a internação do autor, no valor de R$48.268,39 *(Internação hospitalar: R$17.846,40; Aplicação do medicamento pela médica especialista: R$9.980,00; Fisioterapia motora e respiratória: R$14.571,99; Fisioterapia motora – período de transporte: R$2.800,00; Fonoaudiologia e terapia ocupacional: R$3.070,00),* no período de 11-4-2024 a 01-5-2024, observada as notas fiscais indexadas com a inicial.

O valor a ser reembolsado deverá ser corrigido pelo IPCA desde a data dos desembolsos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (26-06-2024 data da confirmação da citação eletrônica - Evento 14), tudo até 29-8-2024.

Após, a partir de 30-8-2024, incidirá correção monetária e juros de mora unicamente pela Taxa Selic, observado o regramento dos art.389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil, com alteração dada pela lei nº14.905 de 28-6-2024.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA FORA DA *ÁREA* DE *ABRANGÊNCIA* DO *PLANO*. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. ROL DA ANS QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DIREITO AO TRATAMENTO. *REEMBOLSO* INTEGRAL DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA POR MAIORIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 52251308920228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 27-11-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. *SAÚDE*. DIREITO À *SAÚDE*. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS TERAPIAS NA CLÍNICA EM QUE A CRIANÇA REALIZA OS TRATAMENTOS. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A URGÊNCIA NAS INTERVENÇÕES E A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. REFORMA DA DECISÃO DA ORIGEM. A NATUREZA DOS *PLANOS* DE *SAÚDE* FAZ COM QUE OS CONSUMIDORES OS BUSQUEM VISANDO SEGURANÇA, PREVISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA EVENTUAIS PROBLEMAS FUTUROS, COLOCANDO O SEGURADO EM SITUAÇÃO DE EVIDENTE VULNERABILIDADE PERANTE OS FORNECEDORES DESSES SERVIÇOS DE *SAÚDE*. CASO EM QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A AUTORA INICIOU O TRATAMENTO CUSTEADO DE FORMA PARTICULAR EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO NA *ÁREA* DE *ABRANGÊNCIA* DO CONTRATO. SITUAÇÃO EM QUE A UNIMED NÃO COMPROVOU DISPOR DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NAS REFERIDAS CLÍNICAS, NEM MESMO HAVER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DE *REEMBOLSO* DOS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS PROFISSIONAIS NO ÂMBITO PARTICULAR. LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A URGÊNCIA NAS INTERVENÇÕES E A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52849658920248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-02-2025)

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação proposta por **EMANUEL DA ROCHA PALAVRO**, representado pela genitora Karen Adriana da Rocha, contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o plano de saúde réu ao reembolso integral do valor despendido para aplicação da medicação Zolgensma, no valor de R$48.268,39 *(Internação hospitalar: R$17.846,40; Aplicação do medicamento pela médica especialista: R$9.980,00; Fisioterapia motora e respiratória: R$14.571,99; Fisioterapia motora – período de transporte: R$2.800,00; Fonoaudiologia e terapia ocupacional: R$3.070,00),* no período de 11-4-2024 a 01-5-2024, observada as notas fiscais indexadas com a inicial. O valor a ser reembolsado deverá ser corrigido pelo IPCA desde a data dos desembolsos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (26-06-2024 data da confirmação da citação eletrônica - Evento 14), tudo até 29-8-2024. Após, a partir de 30-8-2024, incidirá correção monetária e juros de mora unicamente pela Taxa Selic, observado o regramento dos art.389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil, com alteração dada pela lei nº14.905 de 28-6-2024.

Diante da sucumbência, condeno a parte demandada ao pagamento da taxa única e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada. Exegese do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Intimações agendadas no sistema.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 13/03/2025, às 15:50:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10078458426v29** e o código CRC **53f5bf33**.

---

1. https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-inclui-medicamento-para-atrofia-muscular-espinhal-no-rol-de-coberturas-obrigatorias ↩